

Epilepsia

1. Introducción y relevancia clínica

La **epilepsia** es un trastorno neurológico crónico caracterizado por la **presencia recurrente de crisis epilépticas**, producto de una **descarga excesiva y sincronizada de neuronas corticales**.

Se estima que afecta a cerca del **1% de la población mundial**, y en Chile, la prevalencia es similar, con alrededor de **150.000 personas diagnosticadas** (MINSAL, 2023).

Una **crisis epiléptica** se define como un evento clínico transitorio, resultado de una descarga neuronal anormal, que puede manifestarse como alteración de la conciencia, movimientos involuntarios, fenómenos sensitivos, autonómicos o conductuales.

El diagnóstico y manejo adecuado de la epilepsia son fundamentales, pues **más del 70% de los pacientes puede alcanzar control completo de las crisis** con tratamiento farmacológico oportuno.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es recurrente por su valor clínico y su presencia tanto en escenarios de urgencia como en el manejo ambulatorio de pacientes neurológicos.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El cerebro mantiene un equilibrio entre excitación e inhibición neuronal. En la epilepsia, este equilibrio se rompe a favor de la **excitación**, principalmente por alteraciones en los canales iónicos, neurotransmisores o redes neuronales.

2.1. Mecanismos fisiopatológicos

- **Hiperexcitabilidad neuronal:** aumento del flujo de sodio y calcio intracelular.
- **Disminución de inhibición gabaérgica:** menor acción del GABA (ácido gamma-aminobutírico).
- **Cambios estructurales:** lesiones corticales, cicatrices glióticas, displasias.
- **Factores genéticos:** mutaciones en genes de canales iónicos.

Estas alteraciones pueden generar **focos epilépticos** que se activan espontáneamente o frente a estímulos (sueño, estrés, fiebre, luz, abstinencia alcohólica).

2.2. Clasificación de las crisis epilépticas (ILAE 2022)

1. **Crisis focales:** se originan en una región cortical limitada.
 - **Focal con conciencia preservada:** síntomas motores o sensitivos localizados, sin pérdida de conciencia.
 - **Focal con alteración de conciencia:** desconexión breve del entorno, automatismos.
 - **Focal bilateral tónico-clónica:** generalización secundaria.
2. **Crisis generalizadas:** afectan simultáneamente ambos hemisferios.
 - **Tónico-clónicas (gran mal):** pérdida de conciencia, rigidez, movimientos clónicos, fase postictal.
 - **Ausencias (pequeño mal):** desconexión breve, mirada fija, sin caída.
 - **Mioclónicas:** sacudidas breves.
 - **Atónicas:** pérdida súbita de tono, caída brusca.
3. **Crisis de origen desconocido:** cuando no puede establecerse el foco.

2.3. Clasificación etiológica

- **Epilepsia estructural:** secundaria a trauma, tumores, ACV, malformaciones.
- **Epilepsia genética:** idiopática, sin causa estructural evidente.
- **Epilepsia metabólica/infecciosa:** hipoglicemia, hiponatremia, neurocisticercosis, VIH, meningitis.
- **Epilepsia inmunológica o criptogénica:** sin causa determinada.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El diagnóstico clínico se basa en **la descripción del episodio** (por el paciente o testigos) y **la identificación de factores precipitantes**.

3.1. Manifestaciones clínicas según tipo de crisis

Crisis focal con conciencia preservada:

- Movimientos clónicos de una extremidad, parestesias o síntomas visuales localizados.
- Conciencia intacta, sin fase postictal.

Crisis focal con alteración de conciencia:

- Detención de la actividad, mirada fija, automatismos orales o manuales, desconexión breve.
- Recuperación con confusión postictal.

Crisis tónico-clónica generalizada:

- Pérdida de conciencia súbita, caída, rigidez (fase tónica), seguida de sacudidas (fase clónica).
- Puede acompañarse de mordedura de lengua, incontinencia urinaria y período postictal con somnolencia.

Crisis de ausencia:

- Inicio y término bruscos, mirada fija, sin movimientos ni caída, duración <10 s.
- Común en niños; evocada por hiperventilación.

Crisis mioclónicas:

- Sacudidas breves, repetitivas, especialmente al despertar.

3.2. Diagnóstico diferencial

- **Síncope:** asociado a hipotensión o emociones; recuperación rápida.

- **Crisis psicógenas no epilépticas (PNES):** movimientos desorganizados, sin mordedura lingual ni alteración del EEG.
- **Ataques isquémicos transitorios (AIT).**
- **Migraña con aura.**
- **Hipoglicemia o hipocalcemia.**

Comentario EUNACOM: en los casos clínicos, la presencia de *fase postictal*, *mordedura de lengua* o *incontinencia* orienta fuertemente a epilepsia tónico-clónica.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación inicial

1. **Historia clínica detallada:** testigos, antecedentes, medicación, consumo de drogas.
 2. **Examen neurológico:** focalidad, signos meníngeos, papiledema.
 3. **Glicemia capilar:** descartar hipoglicemia.
-

4.2. Electroencefalograma (EEG)

- Principal herramienta diagnóstica.
 - Muestra descargas epileptiformes (puntas u ondas agudas).
 - Debe realizarse idealmente dentro de las primeras 24–48 h post crisis.
 - EEG normal no excluye epilepsia.
-

4.3. Neuroimágenes

- **Resonancia magnética cerebral (RM):** método de elección.

Detecta lesiones estructurales (tumores, displasias, infartos).

- **TAC:** útil en urgencias o pacientes con trauma o sospecha de hemorragia.
-

4.4. Exámenes complementarios según sospecha

- Electrolitos, calcio, magnesio, función renal y hepática.
 - Tóxicos y drogas.
 - Serologías (neurocisticercosis, VIH).
-

4.5. Criterios diagnósticos (ILAE 2022)

Epilepsia se diagnostica cuando se cumple uno de los siguientes:

1. **≥2 crisis no provocadas separadas por >24 h, o**
 2. **1 crisis no provocada con alto riesgo (>60%) de recurrencia, o**
 3. **Síndrome epiléptico diagnosticado clínicamente.**
-

5. Tratamiento (según MINSAL, ILAE y UpToDate 2024)

5.1. Principios generales

- Confirmar diagnóstico antes de iniciar fármacos.
 - Seleccionar antiepiléptico según tipo de crisis.
 - Iniciar con **monoterapia a dosis bajas**, ajustar lentamente.
 - Asegurar adherencia y evitar factores precipitantes (sueño, alcohol, fármacos).
-

5.2. Tratamiento farmacológico

Crisis focales o parciales:

- **Carbamazepina** (200–400 mg c/12 h).
- Alternativas: lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina.

Crisis generalizadas tónico-clónicas:

- **Valproato de sodio** (10–20 mg/kg/día).
- Alternativas: levetiracetam, lamotrigina, topiramato.

Crisis de ausencia:

- **Etosuximida o valproato.**

Crisis mioclónicas:

- **Valproato o levetiracetam.**

5.3. Reglas básicas de manejo

- Aumentar dosis gradualmente hasta control o efectos adversos.
- Si falla monoterapia → cambiar o asociar otro antiepiléptico.
- No suspender bruscamente el tratamiento (riesgo de estado epiléptico).

Control y seguimiento: cada 3–6 meses con evaluación clínica y, si necesario, niveles plasmáticos.

5.4. Estado epiléptico (emergencia neurológica)

Crisis tónico-clónica continua o repetida por >5 minutos sin recuperación de conciencia.

Tratamiento:

1. **Diazepam 10 mg IV lento o lorazepam 4 mg IV** (puede repetirse).

2. Si persiste: **Fenitoína 20 mg/kg IV** (máx. 50 mg/min).
3. Si refractario: midazolam o propofol en UCI.

Comentario EUNACOM: en urgencia, ante una crisis prolongada, la primera acción es siempre **administrar benzodiacepina IV** y luego buscar causa.

5.5. Otras terapias

- **Cirugía de epilepsia:** para focos bien delimitados refractarios a fármacos.
 - **Estimulación vagal o neuromodulación** en epilepsia resistente.
 - **Dieta cetogénica:** en niños con epilepsia intratable.
-

6. Complicaciones

- **Estado epiléptico:** mortalidad 10–20%.
 - **Trauma craneal o fracturas durante crisis.**
 - **Depresión y ansiedad.**
 - **Efectos adversos de fármacos (hepatotoxicidad, rash, anemia).**
 - **Epilepsia refractaria:** crisis persistentes a pesar de ≥ 2 fármacos adecuados.
-

7. Pronóstico

- Aproximadamente **70% de los pacientes** logra control total con monoterapia.
- 20% requiere terapia combinada o intervenciones quirúrgicas.
- Las crisis controladas durante ≥ 2 años permiten considerar retiro gradual del tratamiento.
- Peor pronóstico: epilepsia sintomática, inicio precoz, foco múltiple o refractariedad.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Una crisis aislada no equivale a epilepsia.
2. En EUNACOM, el diagnóstico diferencial con síncope y PNES es frecuente.
3. Siempre descartar causas reversibles: hipoglicemia, fármacos, intoxicaciones.
4. El **EEG** confirma pero no excluye epilepsia si es normal.
5. El **valproato** es el fármaco más versátil, pero contraindicado en embarazo.
6. El manejo del **estado epiléptico** comienza con **benzodiacepinas IV**.
7. Se debe **evitar suspensión brusca** del tratamiento.

Errores comunes:

- Tratar sin confirmar epilepsia.
- Usar fenitoína en crisis de ausencia.
- Ignorar efectos adversos hematológicos del valproato o carbamazepina.
- No derivar epilepsia refractaria a especialista.
- No aconsejar restricción de conducción post-crisis (mínimo 6 meses sin eventos).

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. La **epilepsia** es una enfermedad crónica caracterizada por **crisis recurrentes no provocadas**.
2. Se clasifica en **focales y generalizadas**, según origen cortical.
3. El diagnóstico es **clínico**, apoyado por **EEG y RM cerebral**.
4. El **tratamiento inicial** es farmacológico, con monoterapia dirigida al tipo de crisis.

5. En **estado epiléptico**, la primera medida es **benzodiacepina IV (diazepam o lorazepam)**.
6. Más del **70% de los pacientes logra control total**, y el manejo multidisciplinario mejora calidad de vida y adherencia.